

monotropism-autism-prevalence-global_ita

Autismo e monotropismo: quanto sono comuni, in realtà?

Una breve ricerca citata — verifica delle cifre regionali sull'autismo e della domanda "quale percentuale di persone è monotropica".

Informativo, non consiglio medico. Queste cifre descrivono quante persone sono contate come autistiche o ottengono un punteggio alto su una scala di monotropismo. Il conteggio dipende fortemente da chi cerca, come e dove. Niente qui è diagnostico.

Sintesi esecutiva

- **L'autismo non è all'1% ovunque.** La cifra globale più pulita è la stima del **Global Burden of Disease (GBD) 2021**, ora adottata dall'OMS: circa **1 persona su 127 (~0,8%)** era nello spettro autistico nel 2021 [1][2]. Per i *bambini*, le revisioni pooled arrivano ancora vicino al **~1 su 100** di lunga data [3]. Gli Stati Uniti — il paese con lo screening più intensivo — riportano **1 su 31 (3,2%)** tra gli 8enni (dati CDC, 2022) [4].
- **Le differenze regionali sono per lo più un artefatto di misurazione, non biologia.** Lo stesso studio GBD ha trovato che il carico legato all'autismo era *più basso* nel Sud-Est/Est asiatico e in Oceania e *più alto* nella super-regione dei paesi ad alto reddito [1]. Quel pattern segue le infrastrutture diagnostiche, la consapevolezza e lo screening — non reali differenze nella frequenza con cui l'autismo si presenta.

- **La tabella regionale spesso citata è sostanzialmente sbagliata per il Medio Oriente e semplificata in eccesso per l'Asia.** Una meta-analisi del 2025 pone la prevalenza pooled del Medio Oriente e Nord Africa (MENA) a soli **~0,14%** (range 0,01% Oman → 2,51% Arabia Saudita) [6], e una meta-analisi asiatica riporta per l'Est Asia **~0,51%** e per la Cina continentale **~0,7%** [5][7] — ben al di sotto del "0,9–1,5%" spesso rivendicato per il mondo arabo.
- **Il monotropismo non ha una "prevalenza" concordata, e la cifra "15–20% delle persone è monotropica" è un errore di categoria.** Il monotropismo è uno stile cognitivo *dimensionale* (un tratto continuo), non una diagnosi. L'unico grande studio empirico — il **Monotropism Questionnaire (MQ)**, Garau et al. 2023 — ha trovato che i partecipanti autistici ottenevano in media **4,15/5** e i non-autistici **3,19/5**, con una sostanziale sovrapposizione [10]. Non afferma **affatto** "X% delle persone è monotropica".
- **L'affermazione ">90% delle persone autistiche è monotropica" è un'affermazione teorica su quanto bene la teoria coglie l'esperienza autistica, non una percentuale misurata.** È difendibile come *validità soggettiva*, fuorviante come *epidemiologia*.

1. Quante persone sono autistiche? (e perché esistono due numeri-titolo)

Circolano due cifre, e rispondono a domande leggermente diverse:

- **~1 bambino su 100.** È la cifra pooled tra dozzine di studi nelle revisioni sistematiche (es. Zeidan et al., 2022) ed è il riassunto *focalizzato-sui-bambini* di lunga data dell'OMS [3]. Riflette studi che per lo più esaminano popolazioni pediatriche.
- **1 persona su 127 (~0,79%), tutte le età.** È la stima modellata del **GBD 2021** — 61,8 milioni di persone nel 2021 — che l'OMS ha ora adottato alla lettera ("Nel 2021 circa 1 persona su 127 aveva l'autismo") [1][2]. È più bassa pro-capite perché copre l'intero arco di vita, incluse le generazioni più anziane che non sono mai state esaminate.

Il divario tra "1 su 100" e "1 su 127" non è una contraddizione: il primo riguarda i bambini, il secondo tutti. Entrambi sono difendibili se si dichiara la popolazione.

Il GBD fornisce anche una chiara ripartizione per sesso — circa **1,06% dei maschi** contro **0,51% delle femmine** (1.064,7 vs 508,1 per 100.000) — che riflette la ben documentata sotto-individuazione di ragazze e donne autistiche, non una differenza biologica di due volte [1].

2. Perché i numeri regionali differiscono (le differenze misurano per lo più il *rilevamento*, non la biologia)

Questo è il singolo punto più importante per leggere qualsiasi tabella regionale. Gli autori del GBD 2021 hanno trovato che il carico sanitario legato all'autismo andava da **126,5 anni di vita aggiustati per disabilità (DALY) per 100.000** nella super-regione Sud-Est asiatico / Est asiatico / Oceania a **204,1 per 100.000** nella super-regione ad alto reddito [1]. In termini semplici: le parti più ricche e con più screening del mondo *trovano* molto più autismo del resto.

I fattori che guidano il divario sono quasi interamente metodologici e sociali:

- **Infrastrutture diagnostiche** — reti di sorveglianza attiva (es. l'ADDM del CDC statunitense) ricercano sistematicamente i casi nelle scuole e nelle cliniche; molti paesi non hanno un sistema del genere e si affidano a cartelle cliniche passive.
- **Criteri e consapevolezza** — il passaggio dal ristretto "disturbo autistico" (DSM-IV) al più ampio spettro autistico (DSM-5, 2013), oltre alla crescente consapevolezza pubblica e professionale, ha aumentato costantemente la prevalenza *individuata* nei paesi che fanno nuovo screening.
- **Stigma, lingua e accesso ai servizi** — in molte regioni l'autismo è sottostimato perché le famiglie affrontano lo stigma, i servizi mancano o gli strumenti di screening non sono validati nella lingua e cultura locali.

Quindi quando una tabella mostra "0,1% nella regione X e 3% nella regione Y", leggetela come *"la regione Y cerca con più attenzione e ha più capacità di diagnosticare"*, non *"l'autismo è trenta volte più raro nella regione X"*. Gli autori del GBD lo sottolineano proprio: serve una migliore copertura globale dei dati prima che la variazione geografica possa essere interpretata con fiducia [1].

3. Una tabella regionale corretta

Le cifre che hanno sollecitato questa breve sono riprodotte a confronto con la migliore evidenza disponibile. Le colonne "stima migliore" citano revisioni sistematiche primarie o il modello GBD — non arrotondamenti di advocacy.

Regione	Cifra spesso citata	Cosa sostiene l'evidenza	Fonte
Mondo — tutte le età	"1%"	1 su 127 (~0,79%) nel 2021 (GBD; ora la cifra dell'OMS)	[1][2]
Mondo — bambini	"1 su 100"	~1 bambino su 100 (revisioni pooled)	[3]
Nord America	"1–3,2%"	3,2% (1 su 31) bambini statunitensi di 8 anni (2022, CDC ADDM); ~1 adulto su 45	[4]
Europa	"0,7–1%"	Gli studi su base di registro si addensano attorno al ~1% (es. Danimarca, Finlandia, Islanda); le stime su base di popolazione sono alquanto più alte	[3]
Medio Oriente e Nord Africa	"0,9–1,5%"	Pooled ~0,14% (IC 95% 0,02–0,36%); range per singolo paese 0,01% (Oman) → 2,51% (Arabia Saudita)	[6]
Est / Sud-Est asiatico	"0,4–1,4%"	Meta-analisi asiatica: Est Asia ~0,51%, Sud Asia ~0,31%, Asia occidentale ~0,35%; Cina continentale ~0,7% (1 su 143); sacche con forte screening (Singapore, Giappone, Corea del Sud) riportano cifre più alte	[5][7]

Due conclusioni dalla tabella:

1. I range **nordamericano** ed **europeo** sono ampiamente corretti — sono le regioni con più screening, quindi i loro numeri elevati sono attesi.
2. La cifra **MENA** è il grande errore. Una prevalenza pooled vicina al **0,14%** quasi certamente riflette *sotto-diagnosi e sorveglianza debole*, non un autismo genuinamente più raro. L'enorme variazione interna alla regione (Oman 0,01% fino ad Arabia Saudita 2,51%) è essa stessa l'indizio: la biologia reale non varia così tanto tra paesi confinanti; la sorveglianza sì [6].

4. L'autismo sta davvero "aumentando"?

La prevalenza-titolo è salita ripidamente — negli Stati Uniti da circa 1 su 150 (2000) a 1 su 31 (2022) [4]. La spiegazione dominante tra gli epidemiologi è una **identificazione migliore e più ampia**, non necessariamente più autismo:

- criteri ampliati (DSM-IV → DSM-5),
- ricerca attiva dei casi (sorveglianza in stile ADDM),
- screening più precoce ed equo tra sesso, razza ed etnia,
- stigma ridotto che porta a più valutazioni.

Gli autori del GBD notano che la prevalenza è stata comparativamente *stabile* dove la qualità dei dati è controllata, e che gli apparenti "aumenti" seguono in larga parte la capacità di rilevamento [1]. Il riassunto onesto: **stiamo sempre più contando un autismo che c'è sempre stato.**

5. Quante persone sono "monotropiche"? (la domanda che non ha una risposta unica)

Il monotropismo (Murray, Lawson & Lesser, 2005) è una spiegazione dell'autismo *basata sull'attenzione*: una mente monotropica concentra le proprie risorse in pochi "tunnel di attenzione" intensamente attivi, invece di distribuire l'attenzione su molti canali (politropismo). Fondamentalmente, è inquadrato come una **differenza nell'allocazione dell'attenzione, non un deficit** — e come uno **spettro**, non una categoria sì/no.

Per questo non esiste una **prevalenza concordata del "monotropismo"**, per tre ragioni strutturali:

1. **Non è una diagnosi.** Il monotropismo non compare nel DSM-5 né nell'ICD-11. Non c'è un registro dei casi né una soglia diagnostica.
2. **È dimensionale, non categoriale.** Tutti possono entrare in uno stato di "flusso" focalizzato; la differenza autistica è che la focalizzazione profonda e ristretta è la *modalità operativa predefinita* anziché uno stato occasionale. Una linea tra "monotropico" e "politropico" sarebbe arbitraria.
3. **Lo strumento riporta medie, non casi.** Lo strumento validato — il **Monotropism Questionnaire (MQ)**, Garau et al. 2023 — restituisce

un punteggio continuo da 1 a 5, e i ricercatori confrontano le *medie di gruppo*, non "quante persone superano una soglia" [10].

I numeri reali che abbiamo (studio di validazione del MQ)

Nello studio di sviluppo del MQ (1.110 partecipanti: 756 autistici, 354 non-autistici) [10]:

- **Partecipanti autistici: media 4,15 / 5** (DS 0,347)
- **Partecipanti non-autistici: media 3,19 / 5** (DS 0,578)
- Lo **stato di ADHD** prediceva indipendentemente punteggi di monotropismo più alti (rilevante perché autismo e ADHD co-occorrono in circa il 30–80% dei casi a seconda della direzione).
- Un'analisi fattoriale esplorativa ha prodotto una **struttura a 8 fattori** (interessi speciali; ruminazione/ansia; bisogno di routine; ambiente e tunnel di attenzione; perdita del contatto con ciò che circonda; decision-making; effetto ansiolitico degli interessi; gestione delle interazioni sociali).

La sovrapposizione tra le due distribuzioni è sostanziale — molte persone non-autistiche ottengono punteggi più alti di alcune persone autistiche, e viceversa. Quella sovrapposizione è *esattamente* il motivo per cui un titolo "% della popolazione è monotropica" non è significativo senza una soglia arbitraria (e contestata).

6. Da dove vengono le cifre ">90%" e "15–20%" — e perché non sono dati di prevalenza

Questi due numeri, che circolano molto online, meritano una verifica diretta.

">90% delle persone autistiche è monotropica." Va letta meglio come un'affermazione di **validità soggettiva** — cioè, *quando le persone autistiche incontrano l'inquadratura del monotropismo, una maggioranza schiacciante la riconosce come una descrizione accurata della propria esperienza*. È un fenomeno reale e significativo (il MQ è stato costruito con un gruppo guidato da persone autistiche proprio perché la descrizione risuonava [10]). Ma **non è una prevalenza epidemiologica**; nessuno studio ha calcolato "la proporzione di persone autistiche che sono monotropiche" rispetto a una soglia validata, perché non c'è una soglia concordata. Enunciata come *"il monotropismo ha un'altissima*

validità soggettiva per le persone autistiche", è difendibile; enunciata come "oltre il 90% delle persone autistiche è monotropico", sopravvaluta ciò che è stato misurato.

"Il 15–20% della popolazione generale è monotropica." Questa cifra è quasi certamente una **confusione con "neurodivergenza"**. Le stime della comunità pongono *una qualche* forma di neurodivergenza (ADHD, dislessia, disprassia, sindrome di Tourette, ecc., con forte sovrapposizione) nell'ordine del 15–20% della popolazione. Per confronto, anche le componenti meglio misurate sono molto più piccole isolate: l'ADHD negli adulti colpisce circa il **2,58%** (persistente) fino al **6,76%** (sintomatico) degli adulti a livello globale [8], e l'ADHD infantile è comunemente stimato attorno al 5–8%. La dislessia è spesso citata vicino al ~10% a seconda della definizione. **Nessuna di queste è una cifra di monotropismo.** Equiparare "neurodivergente" a "monotropico" è un errore di categoria: il monotropismo è una *dimensione* di stile cognitivo che è elevata in — ma non identica a — diversi profili neurodivergenti. Attualmente **non esiste un numero basato sull'evidenza** per la prevalenza del monotropismo nella popolazione generale.

Conclusione sul monotropismo: trattatelo come una tendenza misurabile su uno spettro, fortemente (ma non esclusivamente) associata ad autismo e ADHD, con un'alta validità di esperienza vissuta per le persone autistiche. La risposta onesta a "quale percentuale di persone è monotropica?" è: non è ancora una domanda ben definita, e qualsiasi percentuale precisa che vediate è inventata.

7. Considerazioni pratiche

- **Citate la cifra che corrisponde alla popolazione.** "1 persona su 127" (tutte le età, GBD/OMS) e "~1 bambino su 100" vanno entrambe bene — dichiarate quale intendete [1][2][3].
- **Trattate i divari regionali come divari di rilevamento.** La bassa prevalenza riportata nel MENA, in parti dell'Asia, e tra ragazze/donne, adulti più anziani e gruppi razzializzati riflette sotto-individuazione, non assenza [1][6].
- **Non presentate il monotropismo come se avesse una prevalenza.** Riportate le medie del MQ e l'inquadratura dimensionale; evitate ">90%" e "15–20%" come affermazioni di prevalenza [10].

- **Mantenete l'inquadratura affermante la neurodivergenza.** Una maggiore *individuazione* dell'autismo nei paesi ben attrezzati è un successo di consapevolezza e accesso; monotropico vs politropico è una *differenza nell'attenzione*, non un deficit — coerente con come gli estensori e la comunità autistica inquadrano la teoria.
-

Fonti

[1] Global Burden of Disease Study 2021 Autism Spectrum Collaborators (2024). *The global epidemiology and health burden of the autism spectrum: findings from the Global Burden of Disease Study 2021*. The Lancet Psychiatry (19 dic 2024). doi:10.1016/S2215-0366(24)00363-8 — 61,8 milioni di persone (1 su 127) nel 2021; prevalenza standardizzata per età 788,3/100.000 (maschi 1.064,7; femmine 508,1); DALY per super-regione da 126,5 (Sud-Est/Est asiatico e Oceania) a 204,1 (alto reddito) per 100.000. [https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366\(24\)00363-8/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(24)00363-8/fulltext) · sintesi IHME:

<https://www.healthdata.org/research-analysis/library/global-epidemiology-and-health-burden-autism-spectrum-findings-global>

[2] Organizzazione Mondiale della Sanità (2024). *Scheda informativa sull'autismo (dati chiave)*. — "Nel 2021 circa 1 persona su 127 aveva l'autismo." <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders>

[3] Zeidan, J. et al. (2022). *Global prevalence of autism: A systematic review update*. Autism Research (Wiley). doi:10.1002/aur.2696 — ~1 bambino su 100; dati europei da registro (Francia, Danimarca, Finlandia, Islanda). <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/aur.2696>

[4] CDC, Autism and Developmental Disabilities Monitoring (ADDM) Network (2025). *Prevalence and Early Identification of Autism Spectrum Disorder Among Children Aged 8 Years — ADDM Network, 16 sites, United States, 2022*. MMWR, 74(SS-2). — 1 su 31 (3,2%) tra gli 8enni. Rapporto per la comunità: <https://www.cdc.gov/autism/media/pdfs/2025/04/ADDM-Community-Report-SY2022.pdf> · MMWR: <https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/74/ss/ss7402a1.htm>

- [5] Lu, Y. et al. (2020). *Prevalence of autism spectrum disorder in Asia: a systematic review and meta-analysis*. *Psychiatry Research*, 284, 112679. doi:10.1016/j.psychres.2019.112679 (PMID 31735373) — Est Asia 0,51%, Sud Asia 0,31%, Asia occidentale 0,35%.
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31735373>
- [6] Abdallah, B.M. et al. (2025). *Estimates of the prevalence of autism spectrum disorder in the Middle East and North Africa region: a systematic review and meta-analysis*. *BMC Public Health*, 25:2519. doi:10.1186/s12889-025-23651-x (PMID 40691829) — pooled 0,14% (IC 95% 0,02–0,36%); range per paese da 0,01% (Oman) a 2,51% (Arabia Saudita). <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40691829>
- [7] Jiang, X. et al. (2024). *Prevalence of autism spectrum disorder in mainland China over the past 6 years: a systematic review and meta-analysis*. *BMC Psychiatry* (PMID 38811881) — ~0,7% dal 2017 (~1 su 143). Corroborato da una scoping review di politica del 2024 (SAGE).
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38811881>
- [8] Song, P. et al. (2021). *The prevalence of adult attention-deficit hyperactivity disorder: a global systematic review and meta-analysis*. *General Psychiatry* / PMC7916320 — ADHD adulto persistente 2,58%; ADHD adulto sintomatico 6,76%.
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7916320>
- [9] Murray, D., Lesser, M., & Lawson, W. (2005). *Attention, monotropism and the diagnostic criteria for autism*. *Autism*, 9(2), 139–156. doi:10.1177/1362361305051398 — origine della teoria del monotropismo.
<https://doi.org/10.1177/1362361305051398>
- [10] Garau, V., Woods, R., Chown, N., Hallett, S., Murray, F., Wood, R., Murray, A. & Fletcher-Watson, S. (2023). *The Monotropism Questionnaire* (misura di autovalutazione a 47 item; preprint di validazione). Open Science Framework. — n = 1.110 (756 autistici, 354 non-autistici); media autistici 4,15 (DS 0,347) vs non-autistici 3,19 (DS 0,578) su scala 1–5; l'ADHD prediceva indipendentemente punteggi più alti; struttura a 8 fattori. File del questionario: <https://osf.io/wpx5g> · preprint di validazione: <https://osf.io/ft73y> · licenza: CC BY-NC-SA 4.0. Archivio locale: <sources/17-monotropism-questionnaire-osf.pdf>